

Sepsis — repérage & parcours de soins

Définitions & dépistage



Périmètre de cette fiche : définitions, scores diagnostiques (adulte et enfant), messages clés du parcours de soins complet (prévention → dépistage → prise en charge précoce → prévention des séquelles → accompagnement au long cours), bonnes pratiques de l'hémoculture, facteurs de risque de BMR, et les **Annexes 5 et 6 (Surviving Sepsis Campaign 2021 adulte et 2020 enfant/nouveau-né, validées pour le contexte français) reproduites intégralement** — 149 recommandations au total (84 adulte + 65 enfant). **Hors champ :** le détail des indications vaccinales spécifiques (Annexe 4 — référentiel externe, non actionnable en situation aiguë).

Définitions

Sepsis : dérégulation de la réponse immunitaire à une infection entraînant un dysfonctionnement vital d'organes — score SOFA > 2 points (adulte, sur 24) ; score Phoenix ≥ 2 points (enfant, sur 13).

Choc septique (adulte) : nécessité d'un traitement vasopresseur pour maintenir une pression artérielle moyenne à 65 mmHg **et** une lactatémie ≥ 2 mmol/L.

Choc septique (enfant) : score Phoenix hémodynamique ≥ 1 point (nécessité d'un traitement vasoactif, ou lactatémie ≥ 5 mmol/L, ou hypotension artérielle définie selon l'âge).

qSOFA (repérage du risque de sepsis, hors soins critiques) : PAS < 100 mmHg, fréquence respiratoire > 22/min, altération neurologique centrale (Glasgow < 15) — score à 2 ou 3 = patient à risque.

Dépistage — adulte : ≥ 3 des 6 variables cliniques

Variable	Seuil
Âge	> 65 ans
Température	> 38 °C
Pression artérielle systolique	≤ 110 mmHg
Fréquence cardiaque	> 110 /min
Saturation périphérique en O ₂	≤ 95 %
Fonctions supérieures	Troubles

Dépistage — enfant entièrement déshabillé

- Troubles de conscience ou changement de comportement
- Signes de mauvaise perfusion périphérique : TRC allongé, marbrures, extrémités froides
- Augmentation de la fréquence respiratoire et tachycardie
- Baisse de la pression artérielle
- Apparition et extension de purpura ecchymotique ou nécrotique

Sepsis — repérage & parcours de soins

Scores diagnostiques pédiatriques



Score de sepsis pédiatrique de Phoenix — 4 domaines, 0 à 13 points

Domaine	0 point	1 point	2 points	3 points
Respiratoire (0-3)	PaO ₂ /FiO ₂ ≥ 400 ou SpO ₂ /FiO ₂ ≥ 292	PaO ₂ /FiO ₂ < 400 ou SpO ₂ /FiO ₂ < 292, sous support respiratoire	PaO ₂ /FiO ₂ 100-200 ou SpO ₂ /FiO ₂ 148-220, et VMI	PaO ₂ /FiO ₂ < 100 ou SpO ₂ /FiO ₂ < 148, et VMI
Cardiovasculaire (0-6) — vasoactifs	0 traitement vasoactif, lactate < 5 mmol/L	1 traitement vasoactif (1 pt/traitement, max 3)	≥ 2 traitements vasoactifs (2 pts/traitement, max 6)	Lactate ≥ 11 mmol/L
Coagulation (0-2)	Plaquettes ≥ 100×10 ³ /μL, INR ≤ 1,3, D-dimères ≤ 2 mg/L, fibrinogène ≥ 100 mg/dL	1 critère anormal = 1 pt	≥ 2 critères anormaux = 2 pts	—
Neurologique (0-2)	Glasgow > 10, pupilles réactives	—	Glasgow ≤ 10 ou pupilles fixes bilatérales = 2 pts	—

Seuil PAM (mmHg) pour 1 pt cardiovasculaire, selon l'âge : <1 mois <30 ; 1-11 mois <38 ; 1-2 ans <43 ; 2-5 ans <44 ; 5-12 ans <48 ; 12-17 ans <51. Traitements vasoactifs = adrénaline, noradrénaline, dopamine, dobutamine, milrinone, vasopressine. Score calculable même si des variables manquent (points = 0 si non mesuré). Ne s'applique pas aux nouveau-nés <37 SA ni aux ≥18 ans.

Choc septique pédiatrique = score Phoenix hémodynamique ≥ 1 point (sous-score cardiovasculaire, incluant le critère lactate ≥ 5 mmol/L ou hypotension selon l'âge).

Feux tricolores NICE — risque chez l'enfant fébrile

Signe	Vert (bas risque)	Orange (risque intermédiaire)	Rouge (haut risque)
Coloration (peau, lèvres, langue)	Normale	Pâleur rapportée par les parents ou le référent parental	Pâleur, marbrures, cyanose
Réactivité	Bonne interaction sociale, souriant, bien éveillé ou se réveille facilement, pleurs normaux ou pas de pleurs	Mauvaise interaction sociale, ne sourit pas, ne se réveille qu'à la stimulation prolongée, moins réactif/actif qu'à l'habitude	Aucune interaction, aspect « toxique/malade », inquiétude du professionnel de santé, ne se réveille pas ou moments d'éveil très fugaces, pleurs faibles ou cri continu inconsolable
Respiration	—	Battements des ailes du nez, tachypnée (RR >50/min entre 6 et 12 mois, RR >40/min si >12 mois), saturation en O ₂ ≤ 95 % en air ambiant, crépitations à l'auscultation	Geignement, tachypnée >60/min, tirage intercostal modéré ou important
Circulation et état d'hydratation	Aspect normal de la peau et des yeux, muqueuses bien humectées	Tachycardie (>160/min si <1 an, >150/min entre 12-24 mois, >140/min entre 2-5 ans), TRC ≥ 3 s, muqueuses sèches, refus d'alimentation chez le nouveau-né, oligurie	Pli cutané persistant
Autres	Aucun des signes de la zone orange ou rouge	Âge de 3 à 6 mois avec une fièvre ≥ 39 °C ; fièvre depuis plus de 5 jours ; raideur d'un membre ; gonflement articulaire ou d'un membre ; boiterie, impotence fonctionnelle d'un membre	Âge < 3 mois et fièvre ≥ 38 °C* ; purpura ; fontanelle bombante chez le nourrisson ; raideur de nuque ; état de mal convulsif ; déficit neurologique focalisé ; crise focale

* Certaines vaccinations peuvent induire de la fièvre chez l'enfant de moins de 3 mois.

Sepsis — repérage & parcours de soins

Signes vitaux & messages clés (1/2)



Normes des signes vitaux chez l'enfant (European Resuscitation Council)

	1 mois	1 an	2 ans	5 ans	10 ans
Fréquence respiratoire (/min)					
Valeur haute	60	50	40	30	25
Valeur basse	25	20	18	17	14
Fréquence cardiaque (/min)					
Valeur haute	180	170	160	140	120
Valeur basse	110	100	90	70	60
Pression artérielle systolique (mmHg)					
50ème percentile	75	95	—	100	110
5ème percentile	50	70	—	75	80
Pression artérielle moyenne (mmHg)					
50ème percentile	55	70	—	75	75

Messages clés — parcours de soins complet

Mieux prévenir le sepsis, c'est : respecter le calendrier vaccinal à tous les âges · connaître les facteurs de risque d'évolution vers un sepsis en cas d'infection · respecter les règles d'hygiène.

Mieux dépister le sepsis, c'est : promouvoir des stratégies d'information et de communication afin d'identifier précocement les signes de sepsis, en particulier chez les patients ayant des facteurs de risque de sepsis ; et rechercher les signes cliniques détaillés en page 1 (enfant déshabillé / variables adulte).

Mieux prendre en charge précocement le sepsis, c'est : agir sans délai.

En ville : contacter le 15 sans délai · ne pas réaliser d'examen complémentaire chez l'enfant · prélever chez l'adulte ambulatoire à risque une hémoculture (≥ 40 mL, 2-3 paires aérobie/anaérobie, prélevable en une fois) et/ou ECBU et/ou ECBC · transport médicalisé, quel que soit l'âge, vers un établissement disposant de soins critiques.

À l'hôpital — bundle de la 1ère heure (au mieux) :

- Pose d'une voie d'abord veineuse ou intra-osseuse
- Hémoculture (≥ 40 mL, 2-3 paires aérobie/anaérobie) + dosage du lactate
- Antibiothérapie IV adaptée au site/pathogènes probables, au caractère communautaire ou non, aux facteurs de risque de BMR et à l'écologie locale
- Restauration hémodynamique individualisée guidée par évaluation clinique et échographique : remplissage vasculaire 10-20 mL/kg en 15-20 min, puis agents vaso-inotropes si non-réponse ou mauvaise tolérance au remplissage

Admettre en soins critiques en l'absence de résolution des variables cliniques après traitement initial · respecter les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign pour la suite de la prise en charge.

Sepsis — repérage & parcours de soins

Messages clés (2/2) & hémoculture



Mieux prévenir les séquelles, c'est :

- Dès les 48 premières heures d'hospitalisation : programme de réadaptation standardisé progressif en 6 étapes (mobilisation passive → déambulation dans l'unité) ; réadaptation respiratoire systématique si sepsis pulmonaire initial ou ventilation artificielle
- Puis adaptation de la réadaptation et orientation si besoin vers une équipe mobile de médecine physique et de réadaptation (MPR)
- En post-aigu : orientation vers des équipes de réadaptation pluriprofessionnelles (kinésithérapeute, APA, ergothérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, psychologue, diététicien, travailleur social) coordonnées par un médecin MPR ; suivi ambulatoire sécurisé si retour à domicile ; consultation de suivi dans les 3 mois suivant la sortie

Mieux accompagner au long cours, c'est :

- Évaluation psychologique systématique après le retour à domicile, suivi selon l'évaluation initiale
- Recours à un service d'aide sociale de proximité en situation précaire ou à risque
- Suivi clinique post-sepsis à minima à 3 mois et 1 an de l'hospitalisation

Bonnes pratiques de l'hémoculture

Adulte : volume total optimal 40-60 mL, soit 4 à 6 flacons (8-10 mL/flacon), obtenus en 2-3 ponctions ou en une seule ponction. Limiter à 3 hémocultures (6 flacons) par épisode si patient stable. L'« hémoculture solitaire » (2 flacons/24h) est un indicateur négatif de qualité, à décourager. Soin particulier à l'antisepsie préalable et au remplissage des flacons.

Enfant — volume de sang à mettre en culture selon le poids :

Poids (kg)	Culture 1 (Aér./Anaér., mL)	Culture 2 (Aér./Anaér., mL)	Culture 3 (Aér./Anaér., mL)	Vol. total cultivé (mL)
≤ 1	0,5 à 2 / —	— / —	— / —	0,5 à 2
1,1 - 2	1,5 à 4,5 / —	— / —	— / —	1,5 à 4,5
2,1 - 3,9	3 à 6 / —	— / —	— / —	3 à 6
4 - 7,9	6 / —	— / —	— / —	6
8 - 13,9	4 à 5 / —	4 à 5 / —	— / —	8 à 10
14 - 18,9	5 / 5 à 7	5 à 8 / 5 à 7	— / —	20 à 24
19 - 25,9	5 / 5	5 / 5	5 / 5	30
26 - 39,9	10 / 10	10 / 10	— / —	40
≥ 40	10 / 10	10 / 10	10 / 10	60

Ordres de grandeur à ajuster selon le poids exact dans la catégorie (plus le poids est élevé, plus le volume doit se rapprocher du volume supérieur). Un seul flacon (patient ≤ 8 kg) : aérobie ou anaérobie au choix.

Sepsis — repérage & parcours de soins

Facteurs BMR



Facteurs de risque de portage/infection à bactéries multi-résistantes (BMR)

- Antibiotiques dans les 90 jours précédents
- Hospitalisation > 2 jours dans les 90 jours précédents
- Séjour hospitalier actuel > 5 jours
- Dialyse chronique dans les 30 jours
- Soins complexes à domicile (perfusion, pansements complexes)
- Immunodépression (cancer hématologique actif, transplantation, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie chronique $\geq$ 25 mg/j de prednisone, splénectomie, maladie auto-immune)
- Portage de BMR dans l'entourage familial
- Retour de voyage d'une zone d'endémie

Points de vigilance :

- Le choc septique adulte requiert impérativement les 2 critères : vasopresseurs pour PAM 65 mmHg **ET** lactate $\geq$ 2 mmol/L — l'un sans l'autre ne suffit pas à la définition.
- qSOFA sert au repérage du risque, pas au diagnostic : un qSOFA négatif n'élimine pas un sepsis.
- France : jusqu'à cette RBP, aucune recommandation nationale sur la prise en charge globale du sepsis n'existait — la prise en charge aiguë symptomatique et anti-infectieuse détaillée s'appuie sur la Surviving Sepsis Campaign, reproduite intégralement dans les pages suivantes (Annexes 5 et 6).

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 5 (SSC adulte) — dépistage & infection (1/2)



Annexe 5 — Surviving Sepsis Campaign (SSC) 2021, recommandations pour l'adulte validées pour le contexte français. Population par défaut de chaque ligne : patient adulte en sepsis ou choc septique (précisée seulement si différente). Numérotation reprise telle quelle du document source (des numéros sont absents : items exclus de la validation française de la SSC).

1+	Recommandé (forte)	1-	Non recommandé (forte)	2+	Suggéré (conditionnelle)	2-	Suggéré de ne pas faire (conditionnelle)	?	Pas de recommandation possible (preuve insuffisante)
-----------	--------------------	-----------	------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--	----------	--

Dépistage, organisation & prise en charge initiale

Réf.	Recommandation	Grade
1	Adoption par les hôpitaux d'un programme d'amélioration des performances dans la prise en charge du sepsis (protocole de détection des patients graves/à haut risque + protocoles thérapeutiques).	1+
2	Ne pas utiliser un score isolé (qSOFA, SIRS, autre « early warning score ») comme seul outil de dépistage du sepsis/choc septique.	1-
3	Mesure du lactate sérique en cas de suspicion de sepsis.	1+
4	Sepsis et choc septique = urgences médicales : traitement et réanimation à débiter immédiatement.	1+
6	Utiliser des paramètres dynamiques plutôt que l'examen physique seul ou des paramètres statiques seuls pour guider le remplissage vasculaire.	2+
7	Guider la réanimation sur la baisse de la lactatémie chez les patients dont elle est élevée, plutôt que de ne pas utiliser le lactate.	2+
8	Utiliser le temps de recoloration cutanée comme mesure adjonctive aux autres paramètres de perfusion pour guider la réanimation.	2+
9	Objectif initial de pression artérielle moyenne à 65 mmHg plutôt que des objectifs supérieurs.	1+
10	Admettre en réanimation dans les 6 heures les patients qui le nécessitent.	2+

Prise en charge de l'infection (1/2)

Réf.	Recommandation	Grade
11	Réévaluation permanente + recherche de diagnostics alternatifs + arrêt des antimicrobiens probabilistes si infection non confirmée et cause alternative démontrée/fortement suspectée.	1+
12	Administration immédiate d'antimicrobiens (idéalement dans l'heure) en cas de choc septique possible ou forte probabilité de sepsis.	1+
13	Réévaluation rapide de la probabilité infectieuse vs non infectieuse en cas de sepsis possible sans choc (cf. bonnes pratiques hémoculture, page précédente).	1+
14	Durée limitée d'investigation rapide puis, si le problème persiste, antimicrobiens dans les 3 h à partir de l'identification du sepsis (sepsis possible sans choc).	2+
15	Différer les antimicrobiens en cas de faible probabilité d'infection et absence de choc, avec surveillance rapprochée.	2+
16	Ne pas utiliser la procalcitonine associée à l'évaluation clinique pour décider du moment de débiter les antimicrobiens, par rapport à l'évaluation clinique seule.	2-
17	Antimicrobiens probabilistes couvrant le SARM chez les patients à haut risque d'infection à SARM.	1+
18	Ne pas utiliser d'antimicrobiens couvrant le SARM chez les patients à faible risque.	2-
20	Ne pas utiliser 2 antimicrobiens probabilistes à Gram négatif (plutôt qu'1 seul) chez les patients à faible risque de BMR.	1-
21	Ne pas utiliser de double couverture antimicrobienne dès que le micro-organisme et sa sensibilité sont identifiés.	2-
22	Traitement antifongique probabiliste chez les patients à haut risque d'infection fongique.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 5 (SSC adulte) — dépistage & infection (1/2)



Réf.	Recommandation	Grade
23	Ne pas utiliser de traitement antifongique probabiliste chez les patients à faible risque d'infection fongique.	2-
24	Pas de recommandation sur l'utilisation des agents antiviraux.	?
25	Perfusions prolongées de bêtalactamines après le bolus initial, plutôt qu'une perfusion en bolus conventionnelle.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 5 (SSC adulte) — infection (2/2), hémodynamique & respiratoire



Prise en charge de l'infection (2/2)

Réf.	Recommandation	Grade
27	Identification/exclusion rapide d'un diagnostic anatomique nécessitant un contrôle du foyer infectieux en urgence, et mise en œuvre de ce contrôle dès que médicalement et logistiquement possible.	1+
28	Retrait rapide des dispositifs intravasculaires identifiés comme foyer possible, après mise en place d'un autre accès vasculaire.	1+
29	Réévaluation quotidienne en vue d'une désescalade des antimicrobiens, plutôt que des durées fixes sans réévaluation.	2+
31	Utiliser la procalcitonine + évaluation clinique pour décider d'interrompre les antimicrobiens (contrôle du foyer adéquat, durée optimale indéterminée), plutôt que l'évaluation clinique seule.	2+

Prise en charge hémodynamique

Réf.	Recommandation	Grade
32	Cristalloïdes en première ligne de réanimation liquidienne.	1+
33	Cristalloïdes « balancés » plutôt que sérum salé isotonique.	2+
34	Albumine chez les patients ayant reçu de grands volumes de cristalloïdes.	2+
35	Ne pas utiliser d'hydroxyéthylamidon pour le remplissage vasculaire.	1-
36	Ne pas utiliser de gélamines pour le remplissage vasculaire.	2-
37	Noradrénaline comme vasopresseur de 1ère ligne, par rapport aux autres vasopresseurs.	1+
40	Ne pas utiliser de terlipressine en choc septique.	2-
41	Dysfonction cardiaque avec hypoperfusion persistante malgré volémie/PA adéquates : ajouter la dobutamine à la noradrénaline, ou utiliser l'adrénaline seule.	2+
42	Même situation : ne pas utiliser de lévosimendan.	2-
43	Monitoring invasif de la pression artérielle plutôt que non invasif, dès que réalisable.	2+
44	Initier le vasopresseur sur une voie veineuse périphérique pour rétablir la PAM, plutôt que de retarder son initiation jusqu'à l'obtention d'une voie centrale.	2+

Prise en charge respiratoire

Réf.	Recommandation	Grade
46	Pas de recommandation sur les objectifs d'oxygénation en insuffisance respiratoire hypoxémique liée au sepsis.	?
47	Oxygénothérapie nasale à haut débit plutôt que VNI, en insuffisance respiratoire hypoxémique liée au sepsis.	2+
48	Pas de recommandation sur VNI vs ventilation invasive en insuffisance respiratoire hypoxémique liée au sepsis.	?
49	Ventilation à petits volumes courants (6 mL/kg) plutôt que grands volumes (> 10 mL/kg) en SDRA lié au sepsis.	1+
50	Limite haute de pression de plateau à 30 cmH2O plutôt que pressions supérieures, en SDRA lié au sepsis.	2+
52	Ventilation à petits volumes courants en détresse respiratoire liée au sepsis sans SDRA.	2+
54	Si des manœuvres de recrutement sont utilisées : ne pas utiliser de titration incrémentale de la PEEP.	1-
55	Décubitus ventral > 12 h en SDRA modéré à sévère lié au sepsis.	1+
56	Bolus intermittents de curares non dépolarisants plutôt que perfusion continue, en SDRA modéré à sévère lié au sepsis.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 5 (SSC adulte) — infection (2/2), hémodynamique & respiratoire



Réf.	Recommandation	Grade
57	ECMO veino-veineuse en SDRA sévère lié au sepsis si échec de la ventilation mécanique conventionnelle, dans des centres expérimentés.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 5 (SSC adulte) — adjuvants & long cours



Traitements adjuvants

Réf.	Recommandation	Grade
58	Corticoïdes IV en choc septique avec besoins croissants en vasopresseurs.	2+
59	Ne pas utiliser l'hémo perfusion de polymyxine B.	2-
60	Pas de recommandation sur les autres techniques d'épuration sanguine.	?
61	Stratégie transfusionnelle restrictive plutôt que sans limite imposée/libérale.	1+
62	Ne pas utiliser d'immunoglobulines intraveineuses.	2-
63	Prophylaxie de l'ulcère de stress chez les patients avec facteurs de risque de saignement gastro-intestinal.	2+
64	Prophylaxie de la maladie thromboembolique veineuse en dehors de contre-indications existantes.	1+
65	HBPM plutôt qu'HNF pour la prophylaxie de la maladie thromboembolique.	1+
66	Ne pas utiliser la compression mécanique intermittente en prévention de la MTEV en plus de la prophylaxie pharmacologique.	2-
67	Épuration extra-rénale (continue ou intermittente) en cas d'insuffisance rénale aiguë.	2+
68	Ne pas utiliser l'épuration extra-rénale en l'absence d'indication définie.	2-
69	Initiation d'une insulinothérapie à partir d'une glycémie ≥ 10 mmol/L.	1+
70	Ne pas utiliser de vitamine C intraveineuse.	2-
71	Choc septique + hypoperfusion par acidose lactique : ne pas utiliser de bicarbonate de sodium pour améliorer l'hémodynamique/réduire les besoins en vasopresseurs.	2-
72	Choc septique + acidose métabolique sévère ($\text{pH} \leq 7,2$) + insuffisance rénale aiguë (AKIN 2-3) : bicarbonate de sodium.	2+
73	Initiation précoce (dans les 72 h) de l'alimentation entérale si possible.	2+

Objectifs de soins & prise en charge au long cours

Réf.	Recommandation	Grade
74	Discussion sur les objectifs de soins et le pronostic avec le patient et son entourage.	1+
75	Définir les objectifs de soins précocement (dans les 72 h) plutôt que tardivement.	2+
76	Pas de recommandation sur des critères standardisés pour décider d'entamer une discussion sur les objectifs de soins.	?
77	Intégrer le principe de soins palliatifs ($\pm$ consultation dédiée selon jugement médical) dans le plan de traitement si approprié.	1+
78	Ne pas organiser systématiquement une consultation formalisée de soins palliatifs, par rapport à une consultation basée sur le jugement médical.	2-
79	Orientation vers des groupes de soutien pour les survivants et leur entourage.	2+
80	Fiche de transmission avec les informations importantes pour la poursuite de la prise en charge.	2+
81	Pas de recommandation sur un modèle particulier de fiche de transmission.	?
82	Évaluer systématiquement les besoins de soutien économique et social (logement, alimentation, finances, psychologique) et agir en conséquence.	1+
83	Éducation orale et écrite sur le sepsis (diagnostic, traitement, syndrome post-sepsis) avant la sortie et lors du suivi.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 5 (SSC adulte) — adjuvants & long cours



Réf.	Recommandation	Grade
84	Participation de l'équipe soignante aux décisions de sortie post-réanimation pour une planification de sortie acceptable et réalisable.	1+
85	Programme de transition (plutôt que soins standards) lors du transfert vers un service de soins non critiques.	2+
86	Reprise des traitements usuels à la sortie de réanimation et de l'hôpital.	1+
87	Information formalisée (résumé oral et écrit) sur le séjour en réanimation, le sepsis, les diagnostics associés, les traitements et les troubles habituels après un sepsis.	1+
88	Plan de sortie incluant un suivi par des cliniciens compétents en cas de nouvelles séquelles.	1+
89	Pas de recommandation sur le suivi précoce après la sortie vs suivi de routine.	?
90	Pas de recommandation pour ou contre les thérapies cognitives précoces.	?
91	Évaluation et suivi des problèmes physiques, cognitifs et émotionnels après la sortie de l'hôpital.	1+
92	Orientation vers un programme de suivi des maladies post-réanimation, lorsque celui-ci existe.	2+
93	Orientation vers un programme de réadaptation si ventilation mécanique > 48 h ou séjour en réanimation > 72 h.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 6 (SSC pédiatrique) — détection & anti-microbiens



Annexe 6 — Surviving Sepsis Campaign (SSC) 2020, recommandations pour l'enfant (y compris le nouveau-né) validées pour le contexte français. Population par défaut de chaque ligne : enfant en choc septique ou défaillance d'organe liée au sepsis. Grades explicitement indiqués dans le texte source (force + niveau de certitude) — reproduits ici en un seul chip de synthèse.

1+

Recommandé (forte)

1-

Non recommandé (forte)

2+

Suggéré (conditionnelle)

2-

Suggéré de ne pas faire (conditionnelle)

?

Pas de recommandation possible (preuve insuffisante)

Détection, diagnostic, prise en charge générale & anti-microbiens

Réf.	Recommandation	Grade
3	Mise en place et application de protocoles de prise en charge de l'enfant en choc septique ou en défaillance d'organe liée au sepsis.	1+
4	Au moins 1 hémoculture d'au moins 2 mL avant antibiothérapie, dans toutes les situations où cela n'induit pas de retard d'administration (cf. bonnes pratiques hémoculture, page précédente).	1+
5	Choc septique : débuter une antibiothérapie aussi vite que possible, dans l'heure.	1+
6	En l'absence de choc : débuter une antibiothérapie aussi vite que possible, dans l'heure suivant la reconnaissance du sepsis.	2+
7	Traitement empirique à large spectre couvrant les agents pathogènes les plus probables.	1+
8	Dès que pathogène et sensibilité sont connus : réduire le spectre des traitements empiriques.	1+
9	En l'absence de pathogène identifié : réduire le spectre ou arrêter les traitements empiriques selon l'état clinique, l'évolution, le site d'infection et les facteurs de risque, en lien avec l'infectiologie.	1+
11	Enfants immunodéprimés et/ou à très haut risque de germe multirésistant : association d'antibiotiques probabilistes en cas de choc septique ou de défaillance d'organe liée au sepsis.	1+
12	Stratégies de dosage d'antibiotiques fondées sur les principes pharmacocinétiques/pharmacodynamiques, en tenant compte des propriétés spécifiques des médicaments.	1+
13	Évaluer quotidiennement (clinique et biologique) la possibilité d'une désescalade de l'antibiothérapie.	1+
14	Déterminer la durée d'antibiothérapie selon le site d'infection, l'agent causal, la réponse au traitement et le contrôle de la source.	1+
15	Contrôler au plus vite la source de l'infection (tests diagnostiques appropriés, avis d'équipes spécialisées si nécessaire pour prioriser les interventions).	1+
16	Retrait d'un dispositif intravasculaire confirmé comme source de l'infection, après mise en place d'un autre dispositif — le maintien reste parfois possible selon le germe et la balance bénéfices/risques d'une chirurgie.	1+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 6 (SSC pédiatrique) — hémodynamique, respiratoire & métabolique



Remplissage vasculaire, monitoring hémodynamique & traitements vasoactifs

Réf.	Recommandation	Grade
20	Cristalloïdes plutôt qu'albumine pour la réanimation initiale.	2+
21	Cristalloïdes « balancés » plutôt que sérum salé à 0,9 %, en particulier pour les remplissages faisant suite au remplissage initial.	2+
22	Ne pas utiliser les dérivés de l'amidon comme soluté de remplissage.	1-
23	Ne pas utiliser les gélatures comme soluté de remplissage.	2-
24	Pas de recommandation sur la cible de pression artérielle moyenne (5ème ou 50ème percentile pour l'âge).	?
25	La catégorisation clinique seule en choc septique « chaud »/« froid » n'est pas recommandée.	2-
26	Mesure de variables hémodynamiques avancées (au mieux par échographie : débit/index cardiaque, résistances vasculaires systémiques, ScvO ₂), en complément des variables cliniques, quand disponibles. Lactate persistant élevé → réanimation probablement incomplète, poursuivre l'optimisation.	2+
28	Adrénaline plutôt que dopamine.	2+
29	Noradrénaline plutôt que dopamine.	2+
30	Pas suffisamment d'éléments pour recommander un vasopresseur plus qu'un autre en première ligne.	?
33	Pas de recommandation sur l'adjonction d'un inotrope vasodilatateur en cas de dysfonction cardiaque malgré l'usage d'autres agents vasoactifs.	?

Prise en charge respiratoire

Réf.	Recommandation	Grade
34	Pas de recommandation sur le moment exact pour intuber un enfant en choc septique réfractaire aux remplissages et aux catécholamines.	?
35	Ne pas utiliser l'éthomidate pour l'intubation.	2-
36	Essai de ventilation non invasive en cas de SDRA sans indication claire d'intubation et ayant répondu à la réanimation initiale (réévaluation attentive, ne doit pas retarder l'intubation).	2+
37	PEP élevée en cas de SDRA lié au sepsis (niveau exact non déterminé ; effets hémodynamiques délétères plus marqués en choc septique).	2+
38	Pas de recommandation sur les manœuvres de recrutement dans le SDRA lié au sepsis avec hypoxie réfractaire.	?
39	Essai de décubitus ventral en cas de SDRA sévère avec hypoxémie ne répondant pas aux autres thérapeutiques (durée non précisée chez l'enfant).	2+
40	Ne pas utiliser en routine le NO inhalé chez tous les enfants avec SDRA lié au sepsis.	1-
41	NO inhalé en dernier recours si hypoxie réfractaire + défaillance cardiaque droite, une fois les autres stratégies d'oxygénation utilisées.	2+
42	Pas de recommandation sur la ventilation à oscillation haute fréquence en SDRA grave (si utilisée : hypoxie réfractaire uniquement, en attendant un transfert vers un centre d'assistance extracorporelle).	?
43	Curares chez les enfants présentant un SDRA grave lié au sepsis.	2+

Corticostéroïdes & traitement hormonal/métabolique

Réf.	Recommandation	Grade
44	Ne pas utiliser l'hydrocortisone IV si le remplissage vasculaire et le traitement vasopresseur ont restauré l'état hémodynamique.	2-
45	Administration ou non d'hydrocortisone IV, au choix, en cas d'échec du remplissage vasculaire + traitement vasopresseur — recommandé chez l'adulte avec un niveau de preuve élevé, usage pouvant se justifier en choc réfractaire, en particulier si âge physiologique proche de l'adulte.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 6 (SSC pédiatrique) — hémodynamique, respiratoire & métabolique



Réf.	Recommandation	Grade
46	Ne pas instituer de traitement par insuline pour maintenir la glycémie $\leq 7,8$ mmol/L (140 mg/dL).	1-
47	Pas de recommandation sur la cible glycémique précise (consensus d'expérience pour cibler < 10 mmol/L soit 180 mg/dL, sans consensus sur une borne inférieure).	?
48	Pas de recommandation sur une cible calcémique normale (en pratique, cible souvent une calcémie normale dès qu'un vasopresseur est nécessaire).	?
49	Ne pas utiliser la lévothyroxine en routine en situation d'euthyroïdie.	2-
50	Traitement antipyrétique ou attitude permissive de la fièvre, au choix.	2+

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 6 (SSC pédiatrique) — nutrition, transfusion & sources



Nutrition

Réf.	Recommandation	Grade
51	Pas de recommandation tranchée entre nutrition entérale trophique précoce à augmentation lente vs nutrition entérale complète précoce. En pratique : préférence pour débiter une nutrition entérale dans les 48 h, augmentée par étapes.	?
52	Ne pas interrompre l'alimentation sur le seul critère de l'usage d'un traitement vasoactif.	2-
53	Alimentation entérale privilégiée par rapport à la nutrition parentérale dans les 7 premiers jours suivant l'admission.	2+
54	Ne pas administrer de supplémentation en émulsions lipidiques (chez le nouveau-né/prématuré sous nutrition parentérale : données insuffisantes pour trancher).	2-
55	Ne pas surveiller en routine le volume de résidu gastrique.	2-
56	Nutrition entérale par sonde gastrique plutôt que sonde transpylorique, en l'absence de contre-indication.	2+
57	Ne pas administrer de prokinétiques en routine pour le traitement de l'intolérance alimentaire.	2-
58	Ne pas administrer de sélénium.	2-
59	Ne pas administrer de supplémentation en glutamine.	2-
60	Ne pas administrer de supplémentation en arginine.	2-
61	Ne pas administrer de supplémentation en zinc.	2-
62	Ne pas administrer de supplémentation en vitamine C.	2-
63	Ne pas administrer de supplémentation en thiamine.	2-
64	Ne pas administrer de supplémentation en vitamine D.	2-

Transfusion, épuration extra-rénale/échanges plasmatiques, immunoglobulines & prophylaxie

Réf.	Recommandation	Grade
65	Ne pas transfuser de globules rouges si Hb $\geq$ 7 g/dL (seuil variable chez le nouveau-né selon le terme, l'âge postnatal et les comorbidités, notamment le canal artériel persistant).	2-
66	Pas de recommandation sur le seuil transfusionnel de globules rouges chez l'enfant en choc septique instable.	?
67	Ne pas transfuser de plaquettes en prophylaxie sur le seul taux de plaquettes, en l'absence de signes hémorragiques.	2-
68	Ne pas transfuser de plasma en prophylaxie en l'absence de signes hémorragiques.	2-
69	Ne pas faire d'échanges plasmatiques en l'absence de syndrome de thrombopénie associée à une défaillance multi-organe (TAMOF).	2-
70	Pas de recommandation pour ou contre les échanges plasmatiques en cas de TAMOF avéré.	?
71	Épuration extra-rénale pour prévenir/traiter une surcharge hydrique ne répondant pas à la restriction hydrique et au traitement diurétique (techniques parfois limitées chez le nouveau-né/prématuré ; considérations éthiques à prendre en compte).	2+
75	Ne pas utiliser en routine les immunoglobulines intraveineuses — possible en choc toxique streptococcique réfractaire aux amines vasopresseurs/inotropes, si disponibles.	2-
76	Ne pas faire en routine de prophylaxie contre l'ulcère de stress (sauf patients à très haut risque, $\geq$ 13 %).	2-
77	Ne pas faire en routine de prophylaxie (mécanique ou pharmacologique) contre la maladie thromboembolique veineuse, sauf populations spécifiques à bénéfice potentiel supérieur aux risques/coûts.	2-

Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge du sepsis du nouveau-né, de l'enfant et de l'adulte : recommandations pour un parcours de soins intégré » — Haute Autorité de Santé (HAS). Promoteurs : SRLF, SFAR, SFMU, SPILF, SOFMER, SFP, SFN, GFRUP, GPIP, SFM, SFMM, SF2H, SFGG, SFSP, CNGE, WAAAR. Coordination : Pr Djillali

Sepsis — repérage & parcours de soins

Annexe 6 (SSC pédiatrique) — nutrition, transfusion & sources



Annane (SRLF). Annexes 5-6 : recommandations de la Surviving Sepsis Campaign (SSC) 2021 (adulte) et 2020 (enfant/nouveau-né), validées pour le contexte français par le groupe de travail HAS.

Version : Validée par le Collège de la HAS le 29 janvier 2025.

Méthodologie : Recommandation pour la Pratique Clinique (RPC) ; grading GRADE (forte/conditionnelle, niveau de certitude) pour les Annexes 5-6 reprenant la Surviving Sepsis Campaign.

URL source :

<https://sfar.org/download/prise-en-charge-du-sepsis-du-nouveau-ne-de-lenfant-et-de-ladulte-recommandations-pour-un-parcours-de-soins-integre/?wpdmdl=75093>

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend les définitions, scores diagnostiques, messages clés, bonnes pratiques d'hémoculture et l'intégralité des Annexes 5 et 6 (Surviving Sepsis Campaign 2021 adulte et 2020 enfant/nouveau-né) du document source, mais ne remplace pas le texte intégral (59 pages, argumentaire complet, Annexe 4 vaccinale) et n'est ni éditée ni validée par la HAS ou les sociétés promotrices. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.